Hva kreves av pasienten?

Pasientkrav, standardisering og lokal variasjon i digital sykehusinformasjon

Forskningsrapport | Oktober 2026

80	16	5
nettsider	behandlinger og undersøkelser	helseforetak

Roy Aulie Jacobsen
Kristiania University of Applied Sciences

Hva kreves av pasienten?

Pasientkrav, standardisering og lokal variasjon i digital sykehusinformasjon

Roy Aulie Jacobsen
Kristiania University of Applied Sciences
RoyAulie.Jacobsen@kristiania.no
https://orcid.org/0000-0002-0906-2780

Forskningsrapport, oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23133196

Anbefalt sitering:
Jacobsen, R. A. (2026). *Hva kreves av pasienten? Pasientkrav, standardisering og lokal variasjon i digital sykehusinformasjon*. https://doi.org/10.5281/zenodo.23133196

Sammendrag

Digital pasientinformasjon skal ikke bare være forståelig, men også hjelpe pasienten med å gjennomføre det som forventes. Rapporten analyserer 80 nettsider om 16 behandlinger og undersøkelser ved fem helseforetak. Resultatene viser store forskjeller i hvor mange handlinger, tidskrav og betingelser pasienten møter, først og fremst mellom ulike behandlinger, men også innen enkelte av de samme undersøkelsene. Hovedpoenget er derfor ikke at informasjonen bør være kortere, men at den bør være tydelig organisert slik at pasienten lettere kan forstå hva som skal gjøres og når.

1. Når pasientinformasjon blir en arbeidsbeskrivelse

Før en pasient møter til koloskopi, kan det være nødvendig å endre kostholdet, kjøpe og bruke tømmingsmiddel, holde styr på flere tidspunkter, håndtere faste medisiner, vurdere bruken av blodfortynnende legemidler og vite når fastlege eller sykehus skal kontaktes. Før et EKG kreves det derimot knapt noen forberedelser. Begge deler er pasientinformasjon, men de legger svært ulike oppgaver på pasienten.

Det er dette spennet rapporten tar utgangspunkt i. Mye av arbeidet med pasientinformasjon handler med god grunn om språk, lesbarhet og forståelse. Men informasjonen har også en praktisk side. Når pasienten får beskjed om ikke å spise etter et bestemt tidspunkt, endre medisinbruk, kontakte avdelingen dersom et vilkår gjelder eller følge instruksjoner i et innkallingsbrev, organiserer teksten handling. Informasjonen fordeler dermed oppgaver mellom helsetjenesten og pasienten.

Med dette som utgangspunkt kan pasientinformasjon vurderes på minst to nivåer. For det første må informasjonen være forståelig. Helseinstitusjoner er avhengige av at informasjon presenteres på en måte som er tilgjengelig for mottakeren, enten den formidles gjennom sosiale medier, nettsider eller brev (Ferguson et al., 2021; Maslowska et al., 2025). For det andre må informasjonen være organisert slik at det er praktisk mulig å gjennomføre det som forventes. En

kort og språklig enkel setning kan fortsatt representere en krevende oppgave dersom den inngår i en kjede av handlinger, tidsfrister og unntak.

Denne rapporten undersøker digital pasientinformasjon fra fem norske helseforetak. Formålet er både å beskrive hvilke krav informasjonen stiller til pasienten, og å undersøke hvor lik eller ulik informasjonen er når behandlinger og undersøkelser sammenlignes på tvers av helseforetak. Dette er særlig relevant når pasienter som skal gjennom den samme undersøkelsen, møter ulike antall handlinger eller tidskrav.

De fem helseforetakene er Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF. Med dette som utgangspunkt stilles tre spørsmål:

1. Hvor mange handlinger, tidskrav og betingelser møter pasienten i digital informasjon før behandling eller undersøkelse?

2. Hvilke typer krav går igjen, for eksempel mat eller faste, medisiner, kontakt med helsepersonell og henvisninger til informasjon som ligger andre steder?

3. Hvor mye varierer kravene mellom ulike behandlinger og undersøkelser, og hvor mye varierer de mellom helseforetak når den samme behandlingen sammenlignes?

1.1 Fra forståelighet til handling

Et nyttig skille går mellom om informasjonen er forståelig, og om den er lett å handle på. Patient Education Materials Assessment Tool (PEMAT), utviklet for Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), er laget for å vurdere nettopp disse to sidene ved pasientinformasjon. En tekst kan være lett å forstå uten at det nødvendigvis er tydelig hva pasienten faktisk skal gjøre. Handlingsrettet informasjon gjør derfor oppgavene konkrete og deler mer komplekse handlinger opp i håndterbare steg (Shoemaker et al., 2014; AHRQ, 2020).

Denne rapporten gjennomfører ikke en full PEMAT-vurdering. I stedet brukes et enklere deskriptivt grep: å telle hvilke handlinger, tidskrav og betingelser informasjonen legger på pasienten. Målet er ikke å gi hver tekst en kvalitetsscore, men å synliggjøre hvor mye pasienten forventes å holde oversikt over, og hvor behovet for tydelig struktur og kommunikativ støtte kan være størst.

1.2 Helsekompetanse er også et systemansvar

Helsekompetanse handler om evnen til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne ta beslutninger om egen helse (Helsedirektoratet, 2021; WHO, 2025). Men helsekompetanse handler ikke bare om hva den enkelte pasient er i stand til å forstå eller gjøre. Også helsetjenesten har et ansvar for å presentere informasjon og organisere tjenester på en måte som gjør dem mulige å bruke. WHO understreker nettopp at menneskers mulighet til å finne, forstå, vurdere og bruke helseinformasjon påvirkes av organisatoriske strukturer og ressursene som er tilgjengelige.

Dette er relevant for analysen i denne rapporten fordi pasienter møter informasjon med ulike forutsetninger. De har ikke nødvendigvis samme erfaring med helsetjenesten, språkferdigheter, digitale ferdigheter, tid eller overskudd til å holde styr på mange instrukser samtidig. Et informasjonsopplegg som krever at pasienten kombinerer flere handlinger, tidspunkter og

unntak på tvers av nettsider, brev og muntlige beskjeder, kan derfor være enkelt å håndtere for noen og langt mer krevende for andre.

Analysen måler ikke pasientenes helsekompetanse eller hvor krevende de selv opplever informasjonen. Den synliggjør i stedet noe av arbeidet helsetjenesten legger på pasienten gjennom informasjonen: hvor mange handlinger, tidskrav og betingelser pasienten forventes å holde oversikt over. Dermed flyttes noe av oppmerksomheten fra spørsmålet om hva pasienten klarer, til spørsmålet om hvordan helsetjenesten kan gjøre oppgaven enklere å gjennomføre.

1.3 Behandlingsbyrde og pasientens arbeid

Et beslektet perspektiv finnes i litteraturen om behandlingsbyrde. Her rettes oppmerksomheten mot arbeidet pasienter må gjøre som følge av behandling og kontakt med helsetjenesten. Dette kan for eksempel være å håndtere medisiner, møte til avtaler, følge kostholdsråd, overvåke egen helse og koordinere informasjon og tjenester (Eton et al., 2012; May et al., 2014). Behandlingsbyrde handler dermed ikke bare om sykdommen i seg selv, men også om oppgavene som følger med det å være pasient.

Shippee et al. (2012) beskriver dette som et forhold mellom arbeidsmengde og kapasitet. Arbeidsmengden består av kravene behandlingen, egenomsorgen og hverdagslivet stiller, mens kapasiteten handler om hvilke fysiske, kognitive, økonomiske og sosiale ressurser pasienten har til å håndtere disse kravene. Når arbeidsmengden blir stor i forhold til kapasiteten, kan det bli vanskeligere å gjennomføre det som forventes. Senere forskning viser også at behandlingsbyrde ofte består av flere typer oppgaver som virker sammen, og at pasienter må prioritere, organisere og koordinere dem i hverdagen (Rosbach & Andersen, 2017).

Det meste av denne forskningen handler om personer med kroniske sykdommer og multimorbiditet. Denne rapporten måler heller ikke behandlingsbyrde i klinisk forstand. Perspektivet er likevel relevant fordi også forberedelser før en undersøkelse kan innebære arbeid som pasienten må utføre på egen hånd: medisiner skal håndteres, tidspunkt skal huskes, mat og faste skal planlegges, og informasjon fra flere kilder kan måtte settes sammen.

I denne rapporten brukes behandlingsbyrde som et bakteppe for et mer avgrenset spørsmål: Hvor mye arbeid forventes pasienten å gjøre på bakgrunn av den digitale informasjonen før oppmøte? Antall handlinger, tidskrav og betingelser sier ikke hvor belastende dette arbeidet oppleves. De synliggjør derimot hvor mye pasienten må holde oversikt over, og hvor behovet for tydelig struktur og kommunikativ støtte kan være størst.

2. Materiale og metode

I denne rapporten analyseres offentlig tilgjengelig pasientinformasjon fra fem norske helseforetak: Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF. Alle fem publiserer pasientinformasjon om behandlinger og undersøkelser på egne nettsider.

For å kunne sammenligne informasjonen på tvers av helseforetakene ble det valgt ut 16 behandlinger og undersøkelser som var tilgjengelige ved alle fem foretak. Det gir et balansert datamateriale på totalt 80 nettsider, med fem nettsider for hver behandling eller undersøkelse.

De 16 behandlingene og undersøkelsene er koloskopi, MR-undersøkelse, CT-undersøkelse, bronkoskopi, lyskebrokkoperasjon, galleblæreoperasjon, elektrokonvertering,

brystkreftoperasjon, spirometri, EKG, mammografi, spinalpunksjon, EEG, gynekologisk undersøkelse, arbeids-EKG og ultralyd av hjertet. Utvalget dekker både diagnostikk og behandling innen flere kliniske områder, men er ikke ment å være statistisk representativt for all digital pasientinformasjon i norsk spesialisthelsetjeneste.

Tabell 1 gir en samlet oversikt over datamaterialet, datainnsamlingen og analysen.

Analyseenhet	Én offentlig tilgjengelig nettside med pasientinformasjon om én behandling eller undersøkelse ved ett helseforetak
Omfang	80 nettsider: 16 behandlinger og undersøkelser × 5 helseforetak
Tilgangsdato	1. oktober 2026
Primære mål	Antall handlinger, tidskrav og betingelser
Supplerende koder	Medisin, mat/faste, hygiene, transport, ta med noe, kontakt/varsling, ekstern informasjon, sikkerhet og konsekvens ved avvik
Analyse	Deskriptiv statistikk, sammenligninger mellom behandlinger og helseforetak og deskriptiv variansdekomponering

2.1 Manuell innholdsanalyse

Det ble gjennomført en manuell innholdsanalyse der hver nettside ble lest og kodet av én koder. Dette er en metodisk begrensning ved studien, fordi materialet ikke er dobbeltkodet og det derfor ikke kan beregnes interkoderreliabilitet. Kodingen tok utgangspunkt i tre hovedmål: handlinger, tidskrav og betingelser.

En handling er en oppgave pasienten forventes å gjøre eller unnlate å gjøre før eller i forbindelse med oppmøte. Et tidskrav er et tidspunkt, tidsvindu, en frist eller et rekkefølgekrav som pasienten må holde styr på. En betingelse er et vilkår som endrer hva pasienten skal gjøre, for eksempel avhengig av medisinbruk, helsetilstand eller andre forhold.

I tillegg ble det registrert om nettsiden inneholdt minst ett krav innen bestemte kategorier: medisin, mat eller faste, hygiene, transport, å ta med noe, kontakt eller varsling, ekstern informasjon, sikkerhetsscreening og konsekvens ved avvik. Disse indikatorene brukes til å beskrive hvilke typer oppgaver og informasjonskrav som går igjen i materialet.

2.2 Hva inngår, og hva ligger utenfor analysen?

Kodingen av datamaterialet tar utgangspunkt i hovedteksten som var tilgjengelig på den aktuelle nettsiden på tilgangsdatoen. Dersom nettsiden viste videre til et innkallingsbrev, fastlegen eller andre dokumenter, ble dette registrert som ekstern informasjon. Innholdet i disse kildene ble ikke kodet som en del av hovedteksten.

Analysen beskriver derfor informasjonen som faktisk var tilgjengelig på den undersøkte nettsiden, og ikke hele informasjonskjeden en pasient kan møte. Dette skillet er viktig. En nettside kan fremstå kort fordi sentrale instrukser ligger i et innkallingsbrev eller gis individuelt, mens en annen nettside kan samle en større del av informasjonen i selve hovedteksten.

Antall krav skal heller ikke forstås som en kvalitetsscore. En behandling kan kreve mange forberedelser og samtidig ha svært god pasientinformasjon. Analysen synliggjør først og fremst hvor mye pasienten forventes å holde oversikt over, og hvordan dette varierer mellom behandlinger og helseforetak.

3. Resultater

De fire delkapitlene nedenfor presenterer resultatene fra fire deskriptive analyser av datamaterialet. Formålet er å beskrive mønstre i de 80 undersøkte nettsidene, ikke å teste hypoteser eller trekke statistiske slutninger utover materialet som er analysert.

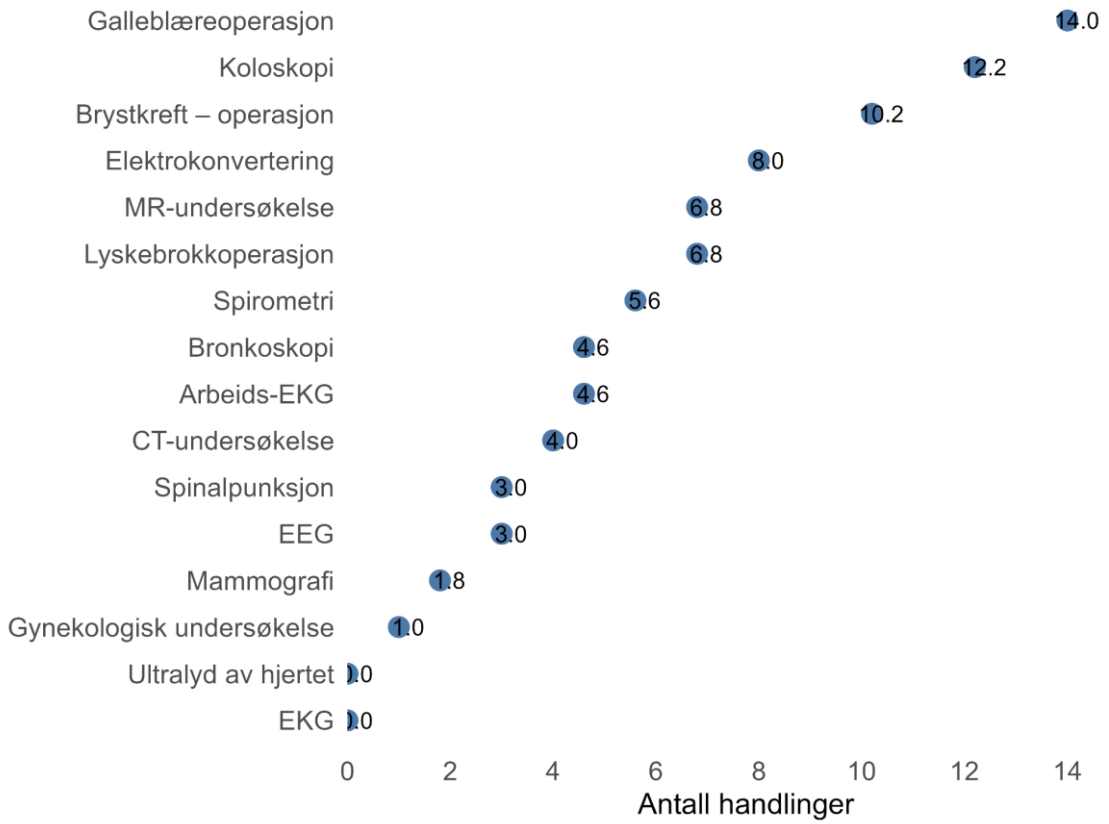
Først undersøkes hvor mange handlinger pasientinformasjonen inneholder, og hvordan dette varierer mellom behandlinger og undersøkelser. Deretter beskrives hvilke typer krav som går igjen i materialet. Den tredje analysen undersøker hvor mye av den observerte variasjonen som er knyttet til behandlingstype og helseforetak. Til slutt brukes koloskopi som et eksempel på hvordan pasientinformasjonen kan variere når den samme undersøkelsen sammenlignes på tvers av fem helseforetak.

3.1 Fra null til fjorten handlinger

I gjennomsnitt inneholder de analyserte nettsidene 5,35 handlinger, mens medianen er fem. 42 av de 80 sidene, tilsvarende 53 prosent, inneholder fem eller flere handlinger. 16 sider har minst ti handlinger. På 59 av sidene finnes det både handlinger, tidskrav og betingelser. Pasienten skal dermed ofte ikke bare gjøre flere ting, men også gjøre dem på bestemte tidspunkter og tilpasse dem dersom bestemte vilkår gjelder.

Det er store forskjeller mellom behandlingene og undersøkelsene. Galleblæreoperasjon har i gjennomsnitt 14 handlinger, mens koloskopi ligger på 12,2 og brystkreftoperasjon på 10,2. Elektrokonvertering ligger på åtte. I den andre enden har EKG og ultralyd av hjertet ingen registrerte forberedelseshandlinger i hovedteksten. Gynekologisk undersøkelse har én handling, mens mammografi har 1,8 i gjennomsnitt.

Antall handlinger skal ikke forstås som en rangering av god og dårlig pasientinformasjon. En operasjon krever naturlig nok mer forberedelse enn et EKG. Det interessante er derfor ikke bare hvor mange oppgaver pasienten får, men hvordan informasjonen er organisert når flere oppgaver skal håndteres samtidig. Jo flere handlinger, tidspunkter og vilkår pasienten må holde oversikt over, desto viktigere blir det at informasjonen er tydelig organisert, at rekkefølgen er enkel å følge, og at unntak og betingelser er lette å finne.



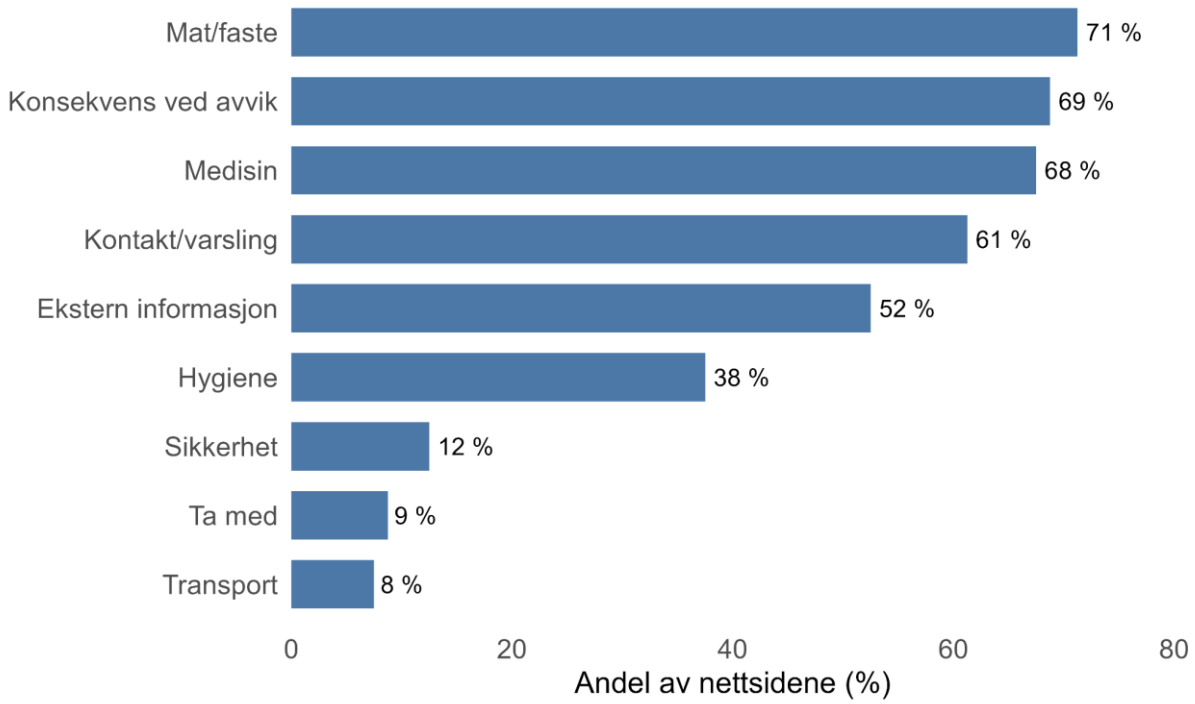
Figur 1. Gjennomsnittlig antall handlinger per behandling eller undersøkelse på tvers av fem helseforetak. N = 80 nettsider. Kilde: egen analyse.

3.2 Pasienten må koordinere mer enn selve teksten

Blant handlingene finnes det flere typer oppgaver pasienten må forholde seg til. Resultatene viser at mat eller faste omtales på 71 prosent av nettsidene. På 69 prosent står det hva som kan skje dersom instruksjonene ikke følges, og 68 prosent inneholder krav knyttet til medisiner. På 61 prosent av sidene skal pasienten kontakte eller varsle helsepersonell i bestemte situasjoner. Hygiene omtales på 38 prosent, mens transport, sikkerhet og krav om å ta med noe forekommer sjeldnere.

Et viktig funn er at 42 av de 80 sidene viser videre til informasjon eller instrukser som ligger et annet sted. Det kan være både riktig og nødvendig. Noen pasienter trenger for eksempel egne råd om medisiner eller andre helseforhold, og enkelte instrukser kan også være knyttet til lokale rutiner. Samtidig kan det bli mer krevende når pasienten må sette sammen informasjon fra nettsiden, innkallingsbrev, muntlige beskjeder, fastlegen eller andre dokumenter.

Da er det ikke nødvendigvis nok at hver enkelt tekst er enkel å forstå. Pasienten må også vite hvilken informasjon som gjelder i egen situasjon, hvilken beskjed som skal følges dersom flere råd ikke er helt like, og hvordan de ulike instruksjonene henger sammen. Dette viser hvorfor det ikke bare er viktig at informasjonen er forståelig, men også at den gjør det enkelt å vite hva man faktisk skal gjøre.



Figur 2. Andel av nettsidene der ulike typer pasientkrav eller informasjonsforhold ble registrert. N = 80 nettsider. Kilde: egen analyse.

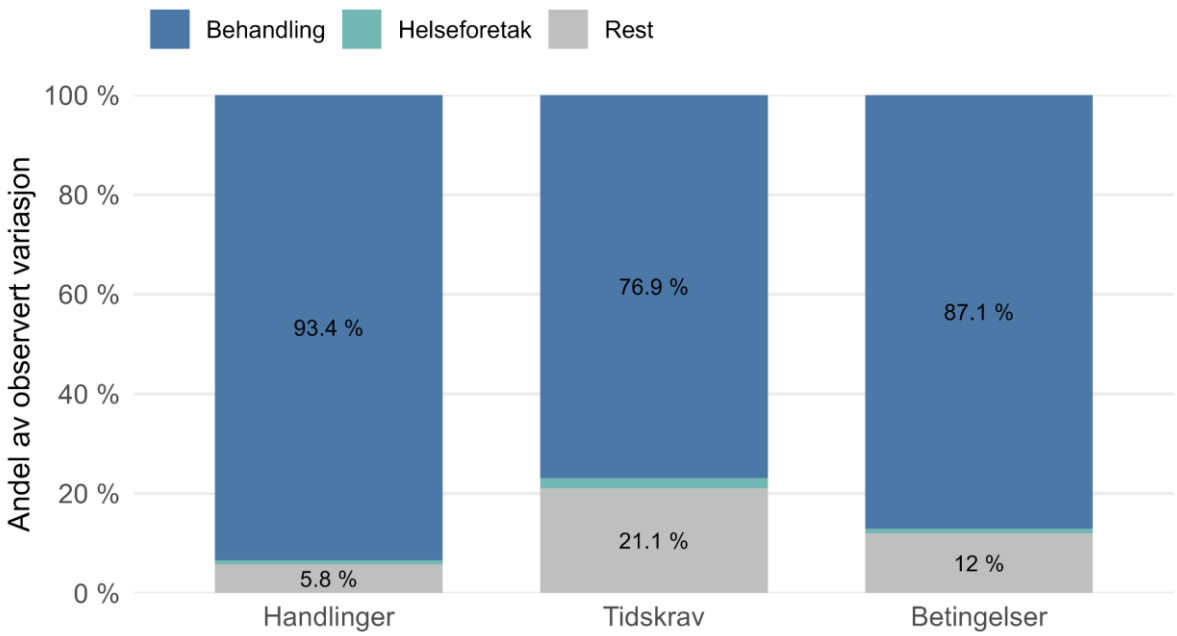
3.3 Behandlingstype betyr langt mer enn helseforetak

Når helseforetakene ses under ett, er forskjellene i antall handlinger forholdsvis små. Gjennomsnittet varierer fra 4,69 handlinger ved Oslo universitetssykehus til 5,69 ved Akershus universitetssykehus. Vestre Viken ligger på 5,25, Sykehuset i Vestfold på 5,50 og Sykehuset Telemark på 5,62. Forskjellene mellom behandlingene og undersøkelsene er langt større. Her varierer gjennomsnittet fra ingen registrerte handlinger til 14.

For å undersøke dette nærmere ble den observerte variasjonen delt opp etter hvor mye som henger sammen med hvilken behandling det gjelder, hvilket helseforetak informasjonen kommer fra, og hvor mye som blir igjen når disse to forholdene er tatt i betraktning. Resultatene viser at 93,4 prosent av variasjonen i antall handlinger kan knyttes til hvilken behandling eller undersøkelse det gjelder. Bare 0,8 prosent kan knyttes til helseforetaket, mens 5,8 prosent ligger i den resterende variasjonen.

Det samme mønsteret går igjen for tidskrav og betingelser. For tidskrav kan 76,9 prosent av variasjonen knyttes til behandlingstype og 2,0 prosent til helseforetaket. For betingelser er tilsvarende tall 87,1 og 0,9 prosent.

Hovedbildet er ganske tydelig. Det er først og fremst hvilken behandling eller undersøkelse pasienten skal gjennom som bestemmer hvor mange krav informasjonen inneholder. Det gir liten mening å beskrive ett helseforetak som generelt mer krevende enn et annet. Forskjeller mellom helseforetakene blir derimot særlig interessante når de oppstår innen den samme behandlingen. Da sammenlignes informasjon om en mer lik situasjon, og det blir relevant å spørre hvorfor pasientene møter ulike instrukser.



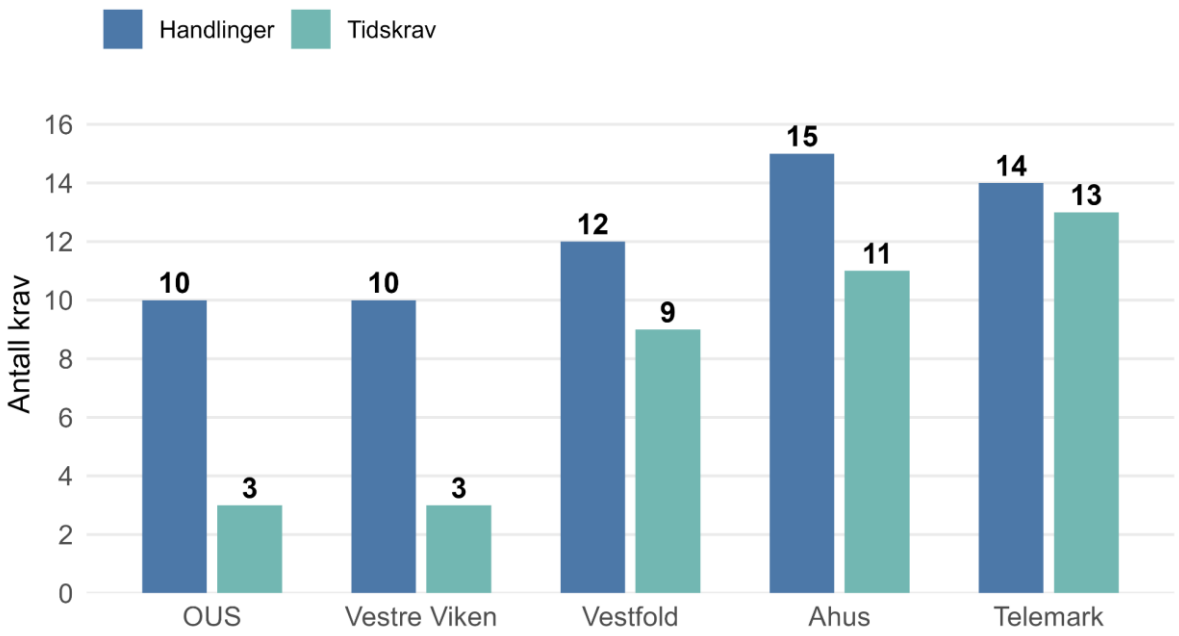
Figur 3. Oppdeling av den observerte variasjonen i handlinger, tidskrav og betingelser. Figuren viser hvor mye av variasjonen som kan knyttes til behandling, helseforetak og den resterende variasjonen. Kilde: egen analyse.

3.4 Koloskopi som eksempel på lokal variasjon

Koloskopi er det tydeligste eksemplet på at pasienter kan møte ulike instrukser selv om de skal gjennom den samme typen undersøkelse. Ved OUS og Vestre Viken er det registrert ti handlinger og tre tidskrav. Sykehuset i Vestfold har 12 handlinger og ni tidskrav. Ahus har 15 handlinger og 11 tidskrav, mens Sykehuset Telemark har 14 handlinger og 13 tidskrav.

Analysen kan ikke fastslå hvorfor forskjellene er så store. De kan skyldes ulike medisinske rutiner, forskjellige tømmingsopplegg, ulik detaljgrad i teksten eller at helseforetakene fordeler informasjonen forskjellig mellom nettsiden, innkallingsbrev og andre kilder. Resultatene gir derfor ikke grunnlag for å si at informasjonen ved ett helseforetak er bedre enn ved et annet.

Det interessante er at pasienter som skal gjennom den samme undersøkelsen, kan få ganske ulike mengder informasjon å forholde seg til. Da blir det relevant å undersøke hvorfor forskjellene finnes. Noen kan være medisinsk nødvendige eller følge av lokale rutiner. Andre kan skyldes hvordan informasjonen har blitt skrevet, oppdatert og organisert over tid.



Figur 4. Antall handlinger og tidskrav i pasientinformasjon om koloskopi ved fem helseforetak. Kilde: egen analyse.

4. Hva betyr funnene for helsekommunikasjon?

Resultatene viser først og fremst at pasientinformasjon ikke bare skal være lett å lese. Den skal også hjelpe pasienten med å gjennomføre det som forventes. Dette blir særlig viktig når informasjonen inneholder mange handlinger, flere tidspunkter og ulike vilkår.

Dette passer godt med forskning på helsekompetanse og pasientinformasjon. WHO understreker at helseinformasjon bør være både forståelig og mulig å bruke, og at helseorganisasjoner har et ansvar for å gjøre informasjon og tjenester lettere å finne fram i og handle på (WHO, 2025). AHRQs verktøy for pasientinformasjon legger på samme måte vekt på at informasjon ikke bare skal forstås, men også tydelig vise hva pasienten skal gjøre (Shoemaker et al., 2014; AHRQ, 2020).

4.1 Informasjonens kvalitet handler også om oppgavearkitektur

Hovedfunnet i denne rapporten er ikke at norske sykehusnettsider inneholder for mye informasjon. Mange behandlinger og undersøkelser krever omfattende forberedelser, og det kan være nødvendig å gi pasienten mye informasjon.

Utfordringen oppstår når pasienten skal holde oversikt over mange oppgaver samtidig. Jo flere handlinger, tidspunkter og vilkår informasjonen inneholder, desto viktigere blir det at den viser en tydelig rekkefølge og gjør det lett å se hva pasienten faktisk skal gjøre.

Dette er også et sentralt prinsipp i PEMAT. Her vurderes blant annet om informasjonen tydelig beskriver handlingene brukeren skal utføre, om større oppgaver deles opp i håndterbare trinn, og om sjekklister eller andre hjelpemidler brukes når det kan gjøre handlingene enklere å gjennomføre (AHRQ, 2020; Shoemaker et al., 2014).

Spørsmålet blir derfor ikke bare om teksten er enkel å forstå, men om den hjelper pasienten med å gjennomføre oppgaven. For behandlinger med mange forberedelser kan dette være minst like viktig som korte setninger og enkelt språk.

4.2 Fragmentering er et eget kommunikasjonsproblem

Et annet funn er at mer enn halvparten av nettsidene viser videre til informasjon som ligger et annet sted. Det kan være et innkallingsbrev, informasjon fra fastlegen eller en individuell beskjed fra sykehuset.

Det er ikke nødvendigvis et problem. Noe informasjon må tilpasses den enkelte pasient. Utfordringen oppstår når pasienten selv må sette sammen flere beskjeder for å forstå hva som skal gjøres.

En nettside kan derfor være godt skrevet og likevel være en del av en vanskelig informasjonskjede. Hvis den generelle nettsiden gir én beskjed og innkallingsbrevet gir mer konkrete råd, bør det være tydelig hvordan informasjonen henger sammen og hvilken beskjed pasienten skal følge.

Dette passer med et bredere syn på helsekompetanse, der helseorganisasjoner har ansvar for å gjøre det enklere å finne fram i, forstå og bruke både informasjon og tjenester (Brach et al., 2012; AHRQ, 2024). AHRQ anbefaler også at pasientinformasjon vurderes som en del av en samlet strategi, og ikke bare som enkeltstående dokumenter eller nettsider.

For behandlinger med mange krav kan det derfor være nyttig å samle de viktigste oppgavene i en enkel rekkefølge: Hva skal gjøres først? Hva skal gjøres dagen før? Hva gjelder på selve dagen? Og hva skal pasienten gjøre dersom noe ikke går som planlagt?

4.3 Standardisering bør brukes strategisk

Resultatene viser at forskjellene mellom helseforetakene samlet sett er små. Samtidig finnes det tydelige forskjeller når den samme behandlingen sammenlignes på tvers av foretakene.

Det betyr ikke at all pasientinformasjon bør være identisk. Ulike medisinske rutiner kan kreve ulike instrukser. Men når informasjonen varierer, bør det være mulig å forklare hvorfor.

Koloskopi er et godt eksempel. Pasientene møter mellom ti og femten handlinger og mellom tre og tretten tidskrav, avhengig av hvilket helseforetak nettsiden tilhører. Denne analysen kan ikke avgjøre om forskjellene skyldes ulike tømmingsopplegg, andre medisinske rutiner eller bare ulik måte å organisere informasjonen på.

Tidligere forskning viser samtidig at pasientinformasjon kan ha betydning for forberedelsene til koloskopi. En systematisk gjennomgang fant at tiltak med ekstra pasientopplæring forbedret kvaliteten på tarmtømmingen i de fleste studiene som ble undersøkt (Kurlander et al., 2016).

Poenget er derfor ikke at alle helseforetak må bruke samme tekst. Det viktigste er å vite hvilke forskjeller som er nødvendige, og hvilke som kan fjernes eller forenkles uten at viktig medisinsk informasjon går tapt.

5. Seks praktiske grep

Funnene i rapporten, sammen med forskning på forståelig og handlingsrettet pasientinformasjon, peker mot seks enkle grep. AHRQ anbefaler blant annet tydelige handlinger, konkrete steg, enkel navigasjon og bruk av tilbakemeldinger fra pasienter når helseinformasjon utvikles og vurderes (AHRQ, 2020; AHRQ, 2024).

1. Gjør det tydelig hva pasienten skal gjøre

Skill det pasienten skal gjøre fra bakgrunnsinformasjon og forklaringer. Bruk tydelige handlingsverb og gjør det enkelt å finne det pasienten faktisk skal gjøre.

2. Sett tidspunktene i riktig rekkefølge

Hvis pasienten skal gjøre flere ting på forskjellige tidspunkter, bør de stå i den rekkefølgen de skal gjennomføres. En enkel tidslinje eller sjekkliste kan være lettere å følge enn flere avsnitt.

3. Gjør unntak lette å finne

Informasjon som begynner med «hvis dette gjelder deg», bør stå tydelig og nær handlingen den påvirker. Pasienten bør slippe å lete gjennom hele teksten for å finne ut om et unntak gjelder.

4. Forklar hvordan ulike beskjeder henger sammen

Hvis nettsiden viser videre til et innkallingsbrev eller en individuell beskjed, bør det stå tydelig hvilken informasjon pasienten skal følge dersom beskjedene ikke er helt like.

5. Gi mest støtte der oppgavene er flest

En behandling med ti eller femten handlinger krever mer støtte enn en undersøkelse med én eller to. Sjekklister, tydelige trinn og visuelle hjelpemidler bør derfor særlig vurderes i de mest krevende forløpene.

6. Test informasjonen med pasienter

Det bør ikke bare testes om pasientene liker teksten, men om de faktisk klarer å bruke den. En enkel test kan være å be en pasient finne riktig tidspunkt for faste, hva som gjelder for medisiner eller hvem som skal kontaktes dersom noe endrer seg. Både WHO og AHRQ understreker betydningen av å utvikle informasjon og tjenester som mennesker faktisk kan forstå og bruke (WHO, 2025; AHRQ, 2024).

6. Begrensninger og veien videre

Rapporten har noen viktige begrensninger. Den analyserer nettsider, ikke pasienter, og kan derfor ikke vise om informasjonen faktisk blir lest, forstått eller fulgt. Den vurderer heller ikke om de medisinske rådene er riktige, eller om forskjeller mellom helseforetak skyldes medisinske eller lokale behov.

Kodingen er gjennomført av én person. Materialet er derfor ikke dobbeltkodet, og det kan ikke beregnes interkoderreliabilitet. Materialet er også et øyeblikksbilde fra 1. oktober 2026 og omfatter fem helseforetak og 16 behandlinger og undersøkelser. Resultatene skal derfor ikke generaliseres til all norsk pasientinformasjon.

Et naturlig neste steg er å undersøke hvordan informasjonen faktisk fungerer for pasientene. Det kan gjøres ved å kombinere denne typen innholdsanalyse med dobbeltkoding, PEMAT, lesbarhetsmål og enkel brukertesting. Særlig interessant vil det være å undersøke om pasienter klarer å finne og gjennomføre de viktigste oppgavene i informasjonstunge forløp.

7. Konklusjon

De 80 nettsidene som er analysert, viser store forskjeller i hvor mye pasienten forventes å gjøre før en behandling eller undersøkelse. Forskjellene skyldes først og fremst hvilken behandling

eller undersøkelse det gjelder. Samlet sett er forskjellene mellom helseforetakene små, men innen enkelte behandlinger finnes det tydelige lokale forskjeller.

Det betyr ikke at informasjon med mange krav er dårlig informasjon. Noen behandlinger krever omfattende forberedelser. Men jo flere handlinger, tidspunkter og vilkår pasienten må holde oversikt over, desto viktigere blir det at informasjonen gjør oppgaven enkel å forstå og gjennomføre.

Koloskopi viser hvorfor det er nyttig å sammenligne den samme undersøkelsen på tvers av helseforetak. Pasientene kan møte ganske forskjellige instrukser selv om undersøkelsen er den samme. Noen forskjeller kan være medisinsk nødvendige. Andre kan skyldes hvordan informasjonen er skrevet og organisert. Det viktige er at forskjellene kan forklares.

Digital pasientinformasjon er derfor ikke bare informasjon om helsehjelpen. Den er også et verktøy pasienten skal bruke for å gjennomføre sin del av forberedelsene.

God pasientinformasjon skal ikke bare være forståelig. Den skal gjøre det tydelig hva pasienten skal gjøre, når det skal gjøres og hva som gjelder dersom noe endrer seg.

8. Referanser

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). (2020). *The Patient Education Materials Assessment Tool (PEMAT) and User's Guide*. https://www.ahrq.gov/health-literacy/patient-education/pemat.html

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). (2024). *AHRQ Health Literacy Universal Precautions Toolkit* (3rd ed.; C. Brach, Ed.). AHRQ Publication No. 23-0075. https://www.ahrq.gov/health-literacy/improve/precautions/toolkit.html

Brach, C., Keller, D., Hernandez, L. M., Baur, C., Parker, R., Dreyer, B., Schyve, P., Lemerise, A. J., & Schillinger, D. (2012). *Ten attributes of health literate health care organizations*. NAM Perspectives. https://doi.org/10.31478/201206a

Eton, D. T., Ramalho de Oliveira, D., Egginton, J. S., Ridgeway, J. L., Odell, L., May, C. R., & Montori, V. M. (2012). Building a measurement framework of burden of treatment in complex patients with chronic conditions: A qualitative study. *Patient Related Outcome Measures, 3*, 39–49. https://doi.org/10.2147/PROM.S34681

Ferguson, C., Merga, M., & Winn, S. (2021). Communications in the time of a pandemic: The readability of documents for public consumption. *Australian and New Zealand Journal of Public Health, 45*(2), 116–121. https://doi.org/10.1111/1753-6405.13066

Helsedirektoratet. (2021). *Befolkningens helsekompetanse: The International Health Literacy Population Survey 2019–2021 (HLS19), del I*. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/befolkningens-helsekompetanse

Kurlander, J. E., Sondhi, A. R., Waljee, A. K., Menees, S. B., Connell, C. M., Schoenfeld, P. S., & Saini, S. D. (2016). How efficacious are patient education interventions to improve bowel preparation for colonoscopy? A systematic review. *PLOS ONE, 11*(10). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164442

Maslowska, E., Guo, Z., Oh, S.-H., & Smit, E. (2025). Exploring public health agencies' communication on social media in the early stages of the COVID-19 pandemic: An

international perspective. *European Journal of Health Communication, 6*(1), 1–26. https://doi.org/10.47368/ejhc.2025.101

May, C. R., Eton, D. T., Boehmer, K., Gallacher, K., Hunt, K., MacDonald, S., Mair, F. S., May, C. M., Montori, V. M., Richardson, A., Rogers, A. E., & Shippee, N. (2014). Rethinking the patient: Using Burden of Treatment Theory to understand the changing dynamics of illness. *BMC Health Services Research, 14*, 281. https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-281

Rosbach, M., & Andersen, J. S. (2017). Patient-experienced burden of treatment in patients with multimorbidity: A systematic review of qualitative data. *PLOS ONE, 12*(6). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179916

Shippee, N. D., Shah, N. D., May, C. R., Mair, F. S., & Montori, V. M. (2012). Cumulative complexity: A functional, patient-centered model of patient complexity can improve research and practice. *Journal of Clinical Epidemiology, 65*(10), 1041–1051. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2012.05.005

Shoemaker, S. J., Wolf, M. S., & Brach, C. (2014). Development of the Patient Education Materials Assessment Tool (PEMAT): A new measure of understandability and actionability for print and audiovisual patient information. *Patient Education and Counseling, 96*(3), 395–403. https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.05.027

World Health Organization (WHO). (2025). *Health literacy*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-literacy

Om rapportforfatteren

Roy Aulie Jacobsen er samfunnsforsker med bakgrunn i politisk kommunikasjon, krisekommunikasjon og kvantitative metoder. Han har levert en doktorgradsavhandling ved Høyskolen Kristiania om politisk kommunikasjon på sosiale medier under covid-19-pandemien. Hans arbeid omfatter blant annet offentlig kommunikasjon, valg, demokrati, sosiale media, medieeffekter og helsekommunikasjon.